EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 69464
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-21 12:51:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOVITA DEL CARMEN MALDONADO PARRA			**RUN**	: 6.545.355-K
F.Nac	: 04-10-1950	**Edad**	: 72 AÑOS, 10 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: CACHAPOAL			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 952283572		
Fecha Ingreso	: 2023-08-21	**Fecha Egreso**	: 2023-08-21 12:51:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G45-ATAQUE DE ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA Y SINDROMES AFINES

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnósticos:
- Sd lacunar. Obs ACV menor subinsular izquierdo.
- Antecedentes: HTA, DM-2, DLP, artrosis

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Diestra mRS 0
Paciente con antecedentes HTA, DM-2 NIR. Presentó en la mañana del 20/08/23 episodio de inició súbito consistente en disartria aislada. En ese entonces transitoria de aproximadamente 30 minutos que regresa en forma espontanea. Posteriormente nuevo evento de mismas carcterísticas que se mantiene por lo que decide consultar.
Al ingreso en SU se registra en DAU FC 72, PA 190/70 mmHg, T° 36.5°C, Sat 97% amb y HGT 173 mg/dL. Al examen solo se describe disartria. Se solicitó estudio complementario de laboratorio en que destaca dislipidemia, sin otras alteraciones de relevancia y TC de encéfalo sin contraste en que se constatan multiples hipodensidades subcorticales corona radiada bilateral, subinsular mayor izquierda y capsulares anteriores. Se realizó a las 24 horas angioTC de cererbro y cuello, sin estenosis significativas extracraneanas, intracraneano con ateromatosis intracraneana difusa no significativa mayor en M2 superoanterior derecha. Evaluación por fonoaudiología apta para alimentación por vía oral.
Se toma conocimiento del caso el 21/08/23 paciente en buenas condiciones generales, afebril, con hemodinamia estable, tendencia a hipertensión, sin monitorización cardiológica. Sin cefalea, sin fluctuación neurológica.
Se solicita control de laboratorio sin alteraciones significativas, considerando estabilidad y estudio completado, se habla con familiar y se plantea alta hospitalaria para seguimiento ambulatorio.

PLAN DE MANEJO:

Estudio: Realizo IPD
- Holter y ecocardiograma en forma ambulatria
- RM de encéfalo stroke ambulatorio por sospecha de vasculopatía
Tratamiento:
- Doble antiagregación y estatinas en dosis altas.
Rehabilitación:
- Kine y fono por 2 veces
Alta HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo movilizar asistida.
2. Régimen papilla hiposódico y diabético, asistido lento.
3. Aspirina 100 mg, 1 comp al día, vía oral.
4. Clopidogrel 75, 1 comp al día, vía oral por 21 días.
5. Famotidina 40 mg, 1 comp al día, vía oral.
6. Atorvastatina 40 mg, 2 comp al día, vía oral.
7. Losartan 50 mg, 1 comp cada 12 horas, vía oral.
8. Control GES ACV en neurología CAE
9. Seguimiento por fonoaudiología
10. Seguimiento por kinesiologia.
11. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

Estudio complementario:
- 21/08/23 Tropo 82.7, Vit B12 353, Folato 32. HbA1c 6.5. RPR no reactivo.
- 21/08/23/ AngioTC de cerebro y cuello: sin estenosis significativas extracraneanas, intracraneano con ateromatosis intracraneana difusa no significativa mayor en M2 superoanterior derecha.
- 20/08/23 TC de encefalo sin contraste: multiples hipodensidades subcorticales corona radiada bilateral, subinsular mayor izquierda y capsulares anteriores
- 20/08/23 Glic 163, Creat 0.6, Uremia 38, ELP 140/4.0/106, Hb 13.2, Hto 40.1, Leuco 5700, Plaq 295.000, PCR 7.7. P Hepático normal. INR 1.02, ColT 234, HDL 49, LDL 105, TGL 398. TSH 1.67. T3L 0.79
- 17/08/23 APS ColT 244, HDL 54, LDL 145, TGL 226. Hb 14.5, Hto 43.5, Leuco 6100, Plaq 296.000, VHS 24. OC no inflamatoria

OBSERVACIONES:

Ex neurológico:
- Mental: Vigil, orientada en tiempo y espacio, atenta, sin alteración del lenguaje, disartria leve
- PC: pupilas isocoricas, RFM +/+, CV conservado, OCM normal sin nistagmus, sensibilidad facial simétrica, leve PFC derecha. Protruye lengua en linea media, paladar blando simétrico.
- Motor: PMP escasa pronación ESD, al testing logra M5 en forma simétrica, ROT normales, plantar extensor bilateral
- Sensitivo: sin déficit multimodal
- Cerebelo: sin hallazgos
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO